



# VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica in Italia

Presentazione riservata per family office e investitori privati · 2026 · "Venere" è un nome di lavoro

#### MISSIONE E VISIONE

# Rendere la medicina estetica accessibile a tutti, nel proprio centro estetico di fiducia.

Portiamo la medicina dove le persone già vanno e di cui già si fidano: cura di sé normale, sicura e vicina. E la visione guarda oltre: rendere accessibile, un domani, anche la **chirurgia estetica del volto**, con una guida clinica di chirurgia maxillo-facciale già nel team.

## Convertiamo i centri estetici in ambulatori di medicina estetica

Non partiamo dalle poche cliniche mediche in vendita (scarse, care, contese). Partiamo dai centri estetici: una platea enorme ed economica, con clientela e footfall già attivi, e ci aggiungiamo la medicina estetica **autorizzata**. Due playbook industrializzati tolgono i colli di bottiglia che fermano tutti gli altri.

### 1 · Playbook autorizzazioni

In Lombardia i trattamenti core (iniettivi, laser medicali) richiedono l'**ambulatorio autorizzato**: è lo step lento e il vero filtro. Noi lo industrializziamo: convertibilità pre-deal, template di sede, partner regolatorio, relazioni con ATS e Comune. Da mesi bespoke a settimane ripetibili. Più è difficile, più è il nostro fossato.

### 2 · Medici condivisi

Un pool di medici che ruota part-time su più sedi (come già fa il nostro CMO). Un direttore sanitario ancora fino a 3 sedi, poi un DS per cluster: medicalizzi molte sedi con pochi medici, ogni sede subito profittevole senza medico full-time.

### 3 · La fiducia è già del centro

È la missione in pratica: portiamo la medicina dove il cliente si fida già. Fedele all'insegna, non a un medico: convertendo ereditiamo quella fiducia e una base clienti calda, e la dipendenza dal medico (rischio n.1) è disinnescata all'origine.

Il roll-up rotola davvero. Il centro estetico paga l'affitto con l'attività non medica mentre autorizzi e converti; il medico condiviso aggiunge margine alto a costo fisso basso; il playbook autorizzazioni replica sede dopo sede. Dove Kliniky e Faceland comprano cliniche mediche care, **noi convertiamo sedi economiche in ambulatori** con medici condivisi.

# Un mercato grande, in accelerazione e frammentato, con la finestra ancora aperta

**1,37M**

procedure di medicina estetica in Italia nel 2024, **+81%** sull'anno prima. 7,3M di italiani trattati (17,6%)

**~80%**

delle procedure sono filler e iniettivi: proprio i trattamenti che richiedono l'**ambulatorio**

**0**

operatori che convertono i centri estetici in ambulatori: il fronte che apriamo noi (le cliniche sono già contese da 5+ fondi)

**~43k**

centri estetici in Italia; **~1.000-1.900 idonei** ad ambulatorio: la platea che convertiamo, ben oltre le poche cliniche in vendita

## L'Europa è già partita

UK: sk:n e Harley Medical aggregate. Il capitale istituzionale arriverà anche in Italia: chi costruisce prima detta i prezzi.

## Vento GLP-1

I farmaci per la perdita di peso creano domanda ricorrente: rimodellamento e skin quality post-dimagrimento.

## Ricambio generazionale

Titolari verso la pensione senza successori: venditori motivati, aperti a earn-out e permanenza.

È la fotografia del dentale e delle farmacie italiane prima del consolidamento. Il nostro ingresso è la coda lunga dei centri estetici (a sconto) da convertire in ambulatori: ogni trimestre di attesa alza i multipli.

## Cinque forze convergono su questa finestra. Non dureranno.

### **Corsa sulle cliniche, fronte beauty aperto**

Le cliniche le consolidano già più fondi (Klinicy verso 60 sedi, Vitaura, Verlinvest, Red Circle). Il fronte dei centri estetici da convertire è ancora libero, ma non per sempre.

### **Ondata di venditori adesso**

Ricambio generazionale: titolari verso la pensione senza successori, aperti a earn-out e rollover. Vendono ora.

### **Domanda in accelerazione**

L'onda GLP-1 crea domanda ricorrente (skin quality e rimodellamento post-dimagrimento) proprio in questi anni.

### **L'Europa ha dato il segnale**

UK e Spagna già consolidate: il capitale arriverà anche qui. Chi costruisce prima diventa la piattaforma da comprare.

### **L'AI è matura adesso**

Per la prima volta agenti e modelli reggono operations multi-sede e decision-support. Chi parte oggi AI-native accumula il dataset.

Queste forze non aspettano. Ogni trimestre di attesa alza i multipli d'acquisto, riduce i venditori disponibili e, poiché i dati compongono, regala a un altro il vantaggio informativo. Il primo che parte non compra solo cliniche: **compra il tempo**.

## Il modello medspa ha già vinto negli USA: da 18 a 49 mld \$

Il medspa è beauty + medicina sotto lo stesso tetto: esattamente ciò che facciamo. In Italia non esiste ancora (beauty e medicina sono separati). Noi lo portiamo convertendo i centri estetici in ambulatori.

### Il mercato (è il nostro modello)

- ◆ Mercato USA oltre 18 mld \$ (2024) verso 49 mld \$ (2030), +15%/anno
- ◆ 10.000+ sedi frammentate: terreno da consolidare
- ◆ Le piattaforme con MSO e membership oltre il 40% valgono 10-13x EBITDA
- ◆ Lo stesso salto in Italia l'hanno già fatto dentale (DentalPro) e farmacie (Hippocrates)

### I roll-up che lo provano

- ◆ LaserAway (Ares): da 74 a 219 sedi in 5 anni, ~150M\$ EBITDA, in vendita oltre 2 mld \$
- ◆ Milan Laser (Leonard Green), SkinSpirit (KKR), Ideal Image (L Catterton)
- ◆ Vince M&A disciplinato + trasformazione operativa, non la tecnologia

## Due motori: arbitraggio dei multipli e trasformazione del formato

### Acquisto · 3-4x

Centri estetici a sconto: cassa e clientela già esistenti.



### Medicalizzazione · +30-50%

Converti in ambulatorio e aggiungi la medicina (medici condivisi) + recurring, mix, saturazione, procurement.



### Piattaforma · 7-10x

Catena nazionale con recurring ~30%, brand e management.

Compriamo centri estetici che generano già cassa (clientela fedele all'insegna, footfall reale) e li convertiamo in ambulatori con un format replicabile e due macchine: playbook autorizzazioni e medici condivisi. Anche senza espansione dei multipli, la crescita dell'EBITDA e la scala generano ritorno: **l'arbitraggio è il moltiplicatore, non la scommessa.**

## Sei caratteristiche: cosa applichiamo a ogni centro convertito

### Recurring su prescrizione

Percorsi programmati a pagamento mensile + membership. Target 15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi, 30% a regime.

### Multi-provider by design

2+ medici e protocolli condivisi: il paziente è fedele al brand e al percorso, non al singolo.

### Mix clinico completo

Iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1: più categorie e più visite per paziente.

### Patient journey da retail

Beauty advisor, consulenza strutturata, follow-up e recall automatici: esperienza premium.

### Pagamenti rateali

Rateizzazione a tasso zero: rende la medicina accessibile, alza il ticket e apre la fascia 25-40.

### Gestione manageriale

GM di area, KPI settimanali (saturazione, conversione, retention), procurement e marketing centrali.

Ogni elemento è già validato nel mercato USA; l'insieme non esiste ancora in nessuna clinica italiana.



## La formalizzazione è il motore del valore, non un costo

Il settore è frammentato, a pagamento e in gran parte informale: è proprio questo a deprimere i multipli d'ingresso. Chi porta trasparenza cattura il re-rating, come nel dentale e nella diagnostica in Brasile e India (da studi grigi a piattaforme premium).

### Rate = tracciabilità

Il pagamento mensile su carta/finanziaria rende il ricavo bianco e allarga il mercato. Formalizzi crescendo.

### Rollover in equity

Il titolare reinveste parte del prezzo in una quota della piattaforma: trasforma reddito personale in capitale tassato e si allinea all'exit di gruppo.

### Compliance = multiplo

Un asset pulito e bancabile vale 7-10x; gli studi grigi 3-4x. La regolarizzazione è l'espansione del multiplo, ed è il moat.

## L'AI non è una promessa a 10 anni: crea valore su tre orizzonti

### Oggi · margine

Agenti gestiscono agende, recall, pricing, procurement e KPI. HQ snello, integrazione più rapida, margini migliori da subito: il vantaggio operativo che uno studio da solo non ha.

### Medio · qualità

Sul dataset reale del gruppo l'AI suggerisce piano e dosaggio, standardizza la qualità e riduce la dipendenza dal singolo medico (il rischio n.1). Il medico decide.

### Lungo · costo

Il dataset di outcome è il substrato per l'automazione delle procedure standardizzate: attacca il costo e il collo di bottiglia dell'ora-medico.

Azienda AI-driven end-to-end (modello Bending Spoons). Lo stesso layer AI che fa girare le sedi guida la macchina di M&A: origination e scoring dei target, filtro di convertibilità autorizzativa, due diligence e integrazione a 100 giorni. Il dataset proprietario di outcome è ciò che la finanza da sola non compra: sposta la valutazione verso un multiplo AI-platform ed è il moat che rende difendibile il roll-up di questo team.

## La clinica resta medica, la piattaforma fa il resto

### Area clinica (per sede)

Direttore sanitario e autorizzazione all'esercizio per struttura; medici condivisi tra sedi; area estetica non-medica separata dall'atto medico; piena autonomia clinica.

### Piattaforma di gruppo

M&A e finanza; brand, marketing, percorsi; procurement centralizzato; GM di area, HR, software e KPI.

### Rete hub & spoke

Ambulatori **hub** (invasivo, alto margine, apertura al chirurgico) + studi medici **satellite** (non invasivo, consulenza, funnel a capex ridotto). Massima copertura, minimo capex per punto.

### Comitato scientifico

Indipendente, sopra il CMO: protocolli e audit.

### Incentivi ≠ volumi

Mai bonus sul venduto: sicurezza e retention.

### Audit & mystery patient

Controlli periodici per sede e consulenza.

### Soglie reputazionali

KPI con blocco espansione al bisogno.

## Cosa compriamo, a quanto, e come strutturiamo

### Il target: centri estetici da convertire in ambulatorio

- ◆ Footfall e clientela già fedele all'insegna
- ◆ Ricavi tipici 0,4-1,5M; base clienti ampia e ripetibile
- ◆ Sede convertibile ad **ambulatorio**: ~90-120 mq, locali distinti, meglio indipendente (filtro pre-deal su destinazione d'uso e requisiti)
- ◆ Bacino 100k+ ab.; cluster (Milano first, poi NO/NE)
- ◆ Titolare disponibile a permanenza + rollover

### Struttura tipo

- ◆ Prezzo 3-4x EBITDA normalizzato
- ◆ 60-70% cash al closing
- ◆ 15-20% earn-out su risultati a 24 mesi
- ◆ 15-25% rollover equity nella piattaforma
- ◆ Non-compete e patti di permanenza

**Pipeline proprietaria.** Origination dal network clinico, congressi, fornitori di iniettabili e dispositivi (che conoscono i volumi reali) e advisor di consolidamenti sanitari italiani. Il deal flow migliore non passa dai broker.

# Dal format lab al primo operatore nazionale

## Fase 1 · mesi 0-18

Format lab + prime conversioni in ambulatorio a Milano. Prova playbook autorizzazioni e tasso di conversione. Avvio raccolta dati.

**Conversione provata, EBITDA/sede +30%**

## Fase 2 · mesi 18-36

Densità regionale: 8-12 sedi in 2-3 cluster (hub & spoke).  
Playbook 100 giorni, procurement pieno, brand, leva bancaria.  
Ingresso del Direttore Operativo dedicato.

**10+ sedi, recurring 20%+, EBITDA 4-6M**

## Fase 3 · mesi 36-60+

Scala nazionale ed exit: 20-30 sedi + dataset maturo. Target dei consolidatori PE / device-maker.

**Exit 7-10x, upside med-tech**

Il data play matura come layer trasversale: da moat di qualità (Fase 1) a decision-support (Fase 2-3) a opzione di automazione (oltre).

# L'economia di una conversione: centro estetico → ambulatorio

|                | All'acquisto | Convertito (24 mesi) |
|----------------|--------------|----------------------|
| Ricavi         | 0,60M        | 1,10M                |
| Margine EBITDA | 15%          | 28%                  |
| EBITDA         | 90k          | 300k                 |

Numeri illustrativi da benchmark, da validare in DD.

### + Medicina estetica in ambulatorio

- ◆ Medico condiviso part-time sulla base clienti esistente: iniettabili ed energy-based ad alto margine
- ◆ Comprato ~3x (~270k) + capex conversione ~250-450k (autorizzazione ambulatorio, locali distinti, impianti, device)
- ◆ Il non-medico paga l'affitto durante la conversione
- ◆ **Ritorno:** ~300k EBITDA a regime; a multiplo medico 8x vale ~2,4M: doppio arbitraggio (sconto + re-rating)

# Il consolidamento delle cliniche è affollato: il fronte dei centri estetici no

| Operatore                              | Cosa consolidano                                 | Backer                    | Beauty → medico | Dato + AI |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Klinicy                                | Cliniche estetiche (verso 60 sedi entro il 2028) | Investitori               | No              | No        |
| Vitaura                                | Cliniche estetiche e longevity                   | LIAN Group (LU)           | No              | No        |
| Faceland · Juneco                      | Cliniche medico-estetiche                        | Verlinvest (BE)           | No              | No        |
| Villa Brasini                          | Clinica estetica premium                         | Red Circle (R. Rosso)     | No              | No        |
| Franchising (He Mediclinic, SkinMedic) | Poliambulatori in affiliazione                   | Parziale (non convertono) | No              | No        |
| VENERE                                 | Centri estetici convertiti in ambulatori         | Family office + debito    | Sì · cuore      | Sì · moat |

Il consolidamento delle cliniche è già competitivo (Klinicy, Vitaura, Verlinvest, Red Circle). Venere apre il fronte inesplorato: acquisire i centri estetici e convertirli in ambulatori, con medici condivisi e moat AI/dati. **Nessuno lo fa.**

## Visione, AI, clinica, operations: competenze complementari



**Luca Martino**  
FOUNDER & CEO

Imprenditore tech, fondatore e CEO di un gruppo AI enterprise in fase di exit. Visione, capitale, M&A, investitori.



**Salvatore Diana**  
CHIEF AI OFFICER

Architetto della piattaforma agentic e del dataset proprietario: outcome tracking, AI decision-support e la roadmap verso l'automazione. Il moat che la finanza non compra.



**Marcello Cammalleri**  
CHIEF MEDICAL OFFICER

Chirurgo specialista maxillo-facciale: anatomia del volto, protocolli e format clinico, direttore sanitario e reclutamento medici. Apre la strada alla chirurgia estetica del volto negli hub. Sotto il comitato scientifico indipendente.



**Simona Cappello**  
COO · DIRETTORE OPERATIVO

Ingegnere e manager nella consulenza, con esperienza HR e formazione da psicologa. Operations multi-sede, persone, integrazione a 100 giorni e P&L per centro.

Contrappesi per costruzione: CFO e board seat dagli anchor investor; comitato scientifico indipendente sopra il CMO; advisor regolatorio-sanitario e fiscale-M&A. Il Direttore Operativo dedicato all'acquisizione entra in Fase 2, a modello provato.



## Un asset che l'AI non erode ma potenzia, con un secondo atto oltre i 10 anni

### Non-disruptabile

L'atto medico è fisico, autorizzato, locale. L'AI qui è un tailwind operativo, non una minaccia sul ricavo.

### Runway 5-10 anni

Più consolidi, più il multiplo si espande e più diventi il n.1 nazionale: la scala lavora a favore.

### Oltre: automazione

Il dataset apre la strada all'automazione delle procedure standardizzate: da servizi a med-tech.

## Cosa può andare storto, e come l'abbiamo progettato

### Autorizzazioni (ambulatorio)

In Lombardia i trattamenti core richiedono l'ambulatorio: capex e tempi più alti. Filtro di convertibilità pre-deal (destinazione d'uso, ~90-120 mq, locali distinti) + playbook + advisor regolatorio. La barra alta è anche il nostro fossato.

### Dipendenza dal medico

Multi-provider obbligatorio, rollover ed earn-out sulla permanenza, fedeltà al brand e al percorso.

### Regolatorio e deontologico

Struttura MSO, comitato scientifico, comunicazione conforme, advisor regolatorio dal giorno uno.

### Conversione beauty → medico

Tasso provato su 1-2 sedi prima di scalare; il ricavo non-medico copre i costi durante la conversione.

### Capitale e capex

L'ambulatorio richiede più capitale per sede: hub & spoke (pochi hub, molti satellite leggeri) e leva bancaria sui flussi contengono il fabbisogno.

### Consolidatori concorrenti

Campo affollato sulle cliniche. La difesa: un fronte diverso (centri estetici) + velocità + moat dati. Chi ha già cluster diventa la piattaforma da comprare.

Il rischio n.1 resta reputazione e qualità clinica: per questo un intero sistema di governance clinica con soglie di blocco.

# I round, in sequenza: proviamo, scaliamo, andiamo nazionali

## Oggi · l'ask · €700k Seed

3 centri a Milano con lettera d'intenti (Marcello DS). Il seed avvia il **primo ambulatorio convertito (pilota)** e blinda la pipeline: proviamo autorizzazioni, tempi ed EBITDA per sede. Check piccolo, rischio basso. La conversione piena dei 3 è la Series A.

## A modello provato · €3-5M Series A

Densità del primo cluster (Milano + NO/NE): 8-12 sedi hub & spoke con playbook autorizzazioni, medici condivisi e macchina AI.

## A densità provata · €10-15M Series B + debito

Scala nazionale: 20-30+ sedi, con leva bancaria sui flussi delle sedi già convertite.

Struttura: club deal di family office con governance attiva (board seat e CFO dagli anchor), tranche legate a milestone. Orizzonte 5-6 anni, exit a PE/strategico, target 7-10x EBITDA e MOIC 2,5-3,5x, con upside dal dataset. **Ti chiediamo ora il Seed da €700k, con prelazione sui round successivi.**



**Grazie.**